EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 88413
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 12-07-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JOSE VALDEMAR PEREIRA VALENZUELA			RUN	: 7.759.244-K
F.Nac	: 02-08-2021	Edad	: 2 AÑOS, 11 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-06-23	Fecha Egreso	: 12-07-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J44.9-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Insuficiencia respiratoria global resuelta
1.1 Traqueobronquitis por H. Influenza
2. EPOC GOLD 3 grupo E
3. Isquemia critica en EID
3.1 Ateromatosis infrarrenal con extensión a territorio ilíaco/Oclusión ateromatosa completa de la AIC derecha/Oclusión del 70% de la AIE derecha e internas bilaterales.
3.2 Extensa enfermedad ateromatosa mixta difusa aortoilíaca y de EEII.
4. ACV isquémico agudo cerebeloso
5. Obs Hepatitis isquémica
6. Antec: HTA/DMT2

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J42.-BRONQUITIS CRONICA NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. E10-DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. N17-INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE MASCULINO, CON LOS ANTECEDENTES Y COMORBIDOS DESCRITOS, CON DOLOR CRONICO EN EXTREMIDADES INFERIORES SEGUN REFIERE HIJA, ACENTUANDOSE EN LOS ULTIMOS 2 DIAS, AUTOVALENTE, QUIEN DE FORMA AGUDA (11 AM) PRESENTA DETERIORO DE NIVEL DE CONCIENCIA, SOMNOLENCIA, DIAFORESIS PROFUSA, MOTIVO POR EL CUAL ES TRAIDO A URGENCIAS DONDE INGRESA A BOX DE REANIMACION Y SE CONSTATA HIPOSATURACIÓN, TAQUICRADIA SINUSAL, RESPUESTA HIPERTENSIVA E INCREMENTO DE RUIDOS RESPIRATORIOS, EXAMENES DESTACAN GSA CON ACIDOSIS DE 7.06 PCO2 102, CREAT 1.6 MG/DL; DIMERO D >3000 Y LDH >5000, SE PROCEDE PREVIA SECUENCIA RAPIDA DE INTUBACION CON FENTANILO + ETOMIDATO Y BNM CON ROCURONIO, A CONECTAR A VMI CON TUBO #8 SIN INCIDENTES, SEDOANALGESIA CON FENTANILO + MIDAZOLAM PARA ESCALON 12, SE DEFINE TRASLADO A UPC UCI PARA MONITORIZACIÓN Y MANEJO Y SE SOLICITA ESCÁNER DE CEREBRO Y ANGIOTC DE TÓRAX.
INICIALMENTE CON SOPORTE DE NAR DURANTE LAS PRIMERAS 24 HORAS , POSTERIORMENTE SE LOGARA SUSPENDER Y AL INICIAR LA SUSPERFICIALIZACION DE LA SEDACION LASA CIFRAS DE PA COMENZARON A SUBIR AMERITANDO HIPOTENSORES, QUE PSOTERIORMENTE SE SUEPENDE. DESDE SU INGRESO HASTA EL

DIS 02/'7/24 SE MANTUVO EN VMI PROTECTIVA, SE EXTUBA SIN INCIDENCIA, SLE CON POCO REQUERIMIENTO DE OXIGENO, CON BUEBNA MECANICA.
AMERITO TTO ATB DE PRIMERA LINEA POR NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD, SE AISLA EN CAT H. INFLUENZA MS. DESCENSO DE PARAMETROS INFLAMATORIOS, DURANTE LA HOSPITALIZACION PRESENTA NUEVO HIGH INFECCIOSO CON FIEBRE Y ALZA DE LA PCR, SE TOMAN NUEVOS CULTIVOS Y SE ESCALA ATB TAZONAM + VANCOMICINA BUENA RESPUESTA, EN CAT REPORTA C. ALBICANS POR LO QUE SE SUSPENDE VANCOMICINA. PACAR ALA BAJA 30.
NEFROMETABOLICO AKI RENAL, AMAERITANDO VOLEMIZACION CON BUENA RESPUESTA, MEJORIA IMPORTANTE FDE LOS PARAMETROS NITROGENADOS, FUNCION REBNAL RECUPERADSA, CREA 0,6, VOLUMEN URINARIO ADECUADAO, CON HIPOCALEMIA EN CORRECION.
EEII AL MONETO DEL INGRESO PRESENTA LIVIDESES Y FRIALDA EN EID, SE SOLICITA ANGIOTAC DE ABDOMEN, PELVIS Y EII DONDE SE EVIDENCIA ATEROMATOSIS INFRARENAL CON EXTENSION A TERRITORIO ILIACO/OCLUSION ATEROMATOSA COMPLETA DE LA AIC DERECHA/OCLUSIVA DEL 70% DE LA AIE DERECHA E INTRENAS BILATERALES, EXTENSA ENFERMEDAD ATEROMATOSA MIXTA DIFUSA AORTOILIACA Y DE EEII, SIENDO EVALUADO POR CIRUGIA QUIENES PLANTEAN AMAPUTACION INFRACONDILEA AL SALIAR DE LA CONDICION GRAVE.
SE REALIZA EDA POR UN EPISODIO DE HEMETEMESIS QUE REPOSTRA GASTRITIS HEMORRAGICA POR L QUE SE SUSPENDE ATICUAGULACION. SE REALIZO TC Y ANGIOTAC DE CUELELO Y CEREBRO POR COMPROMISO DE CONCIENCIA AL INGRESO EVIDENCIA INFARTO AGUDO CEREBELOSO IZQUIERDO(PICA) CON EVOLUCION FAVORABLE, SIN FOCALOZCION NEROLOGICA ALTUAL.
PÁRA EL DIA 8/7/24 EN VISTA DE LA FRANCA MEJORIA CLINICA , SE TRASLADA ALA SERVICIO DE MEDICINA DONDE PERMANEC RECIVIENDO TTO ATB CON MEJORIA CLINICA, SIN REQUERIMIENTO DE OXIGENO.
EL 9/7/24 EN EVALUADAO NUEVAMENTE POR CIRUJANO QUEIN DESCARTA AMPUTACION, ESTUDIO AMBULATORIO CON ESTUDIO VASCUALRA NO INVASIVO
PACIENTE EN ESTABLES CONDICIONES, NORMOCARDICO, HIPERTENSO, CON BUENA MECÁNICA RESPIRATORIA. CUELLO MÓVIL YUGULARES NO INGURGITADASTÓRAX SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE MP PRESENTE DISMINUIDO EN BASE CON CRÉPITOS BIBASAL.CARDIOPULMONAR: RSCSRS NO AUSCULTO SOPLOS. MP (+) AUDIBLES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, SIN AGREGADOS. ABDOMEN: RH+ BLANDO, DEPRESIBLE, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL.EXTREMIDADES: SE PALPA PULSO FEMORAL, POPLÍTEO Y TIBIAL POSTERIOR, PULSO PEDIO AUSENTE EN EID. SIN EDEMA, CON BUENA TEMPERATURA Y LLENE CAPILAR. NEUROLÓGICO: CONSCIENTE, ORIENTADO, OBEDECE ORDENES, SIN LOCALIDAD NEUROLÓGICA EN CONDICIONES DE LATA MEDICA CON HODOM PARA CONTINUARA CON KINE MOTORA Y RESPIRATORIA

PLAN DE MANEJO:

ALTA CON HODOM
IC BRONCOPULMONAR
IC CIRUGIA VASCULAR
CONTROL POLI DE CIRUGIA
CONTROL POLI DE MEDICINA

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO RELATIVO
2. REGIMEN LIVIANO PARA DIABÉTICOS
3. KNT RESP Y MOTORA X 2
4. BREXOTIDE 2PUFF CADA 12HRS
5. B. IPRATROPIO 4PUFF CADA 8 HRS
6. LOSARTAN 50MGRS CADA 12HRS
7. AMLODIPINO 10 MG DIA VO
8. ASA 100MGRS VO DIA
9. ATORVASTATINA 80MGRS VO DIA
10. CILOSTAZOL 100MGRS VO CADA 12HRS
11. QUETIAPINA 25MGRS 1-1-2
12. SLOW K 600 MG 2 COMP CADA 8 HORAS VO
13. DABIGATRAN 15 MG CAD 12 HORAS POR 30 DIAS VO

EXÁMENES Y RESULTADOS

EXÁMENES CONTROL 10/7/24: GLICEMIA : 80 MG/DL CREATININA : 0,70 MG/DL CLEARENCE CALCULADO(MDRD) : 111,49 LACTATO : 1,2 PROTEINA C REACTIVA : 7,0 UREMIA : 33 SODIO (NA) :

140,00 POTASIO (K) : 2,90 CLORO (CL) : 101,00 LEUCOCITOS : 7,30 MIL/UL RECUENTO HEMATIES : 5,22 MILL/UL HEMATOCRITO : 41,2 O/O HEMOGLOBINA : 12,7 G/DL PLAQUETAS : 233 PROCALCITONINA : 0,22

EXÁMENES CONTROL 9/7/24 GLICEMIA : 80 MG/DL CREATININA : 0,70 MG/DL CLEARENCE CALCULADO(MDRD) : 111,49 LACTATO : 1,2 PROTEINA C REACTIVA : 7,0 UREMIA : 33 SODIO (NA) : 140,00 MMOL/L POTASIO (K) : 2,90 * MMOL/L CLORO (CL) : 101,00

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO